PROTOCOLLO 63

Allenamento propriocettivo mandibolare

Migliorare la percezione della posizione mandibolare

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Scarsa consapevolezza della posizione
- ✓ Parafunzioni
- ✓ Dopo lunga immobilità

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Riferimento

Apri fino a una posizione di riferimento con gli occhi aperti.



Ripetizione cieca

Ripeti a occhi chiusi cercando la stessa posizione.



Verifica

Controlla allo specchio.



Variazione

Cambia posizione di riferimento.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10
Serie	2 al giorno
Criterio	precisione

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ La precisione conta più dell'ampiezza
- ✓ Feedback immediato
- ✓ Esercizio breve e frequente

Errori da evitare

- ! Movimenti ampi
- ! Velocità elevata
- ! Saltare la verifica

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Riposizionamento	Ritrovare a occhi chiusi una posizione di apertura	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** La propriocezione mandibolare migliorata favorisce movimenti più economici e meno dolorosi.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.